

# Finalità del Lavoro Sociale: autonomia, empowerment, benessere, qualità di vita, PERMA

TMIS · Sessione 03

Questa lezione è una delle fondamenta del corso: ti dà il vocabolario del lavoro sociale. Non sono parole d'effetto — sono le bussole che orientano ogni intervento. Capirle bene significa capire *perché* esiste questa professione e dove vuole portare le persone.

---

## Le finalità dell'operatore sociale: panoramica

Prima di entrare nei singoli concetti, la lezione ha dedicato ampio spazio a una domanda apparentemente semplice ma insidiosa: *cosa sono le finalità del lavoro sociale, e cosa invece sono solo strumenti?*

I gruppi di studenti hanno presentato diverse proposte — autonomia, fiducia, ascolto attivo, accompagnamento, benessere, inclusione, integrazione. La professoressa ha poi guidato la distinzione: **l'ascolto attivo, per esempio, è uno strumento per raggiungere la finalità. L'autonomia o il benessere sono finalità — le mete verso cui si tende.**

Il punto chiave che è emerso dalla discussione: **si lavora con le persone, non per le persone. Non ci si sostituisce alla persona — la si accompagna perché possa fare da sola.** L'obiettivo ideale dell'operatore sociale? Come ha detto una docente: **diventare inutile.** Lavorare così bene da non essere più necessari.

Un altro punto interessante sollevato dalla classe: non è solo il risultato finale che conta, ma anche **il processo.** La ricerca della soluzione, fatta insieme alla persona, può essere già parte della soluzione stessa.

---

# Qualità di Vita (QdV): il modello multidimensionale

## Definizione

Il concetto di **Qualità di Vita** è studiato da molte discipline e ogni disciplina ha sviluppato una propria prospettiva. Nel lavoro sociale, il riferimento principale è il modello di **Schalock e Verdugo (2006/2008)**.

L'OMS (1995) definisce la QdV come:

«La percezione dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito, e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi.»

Una definizione più operativa è quella di Renwick e Brown: *il grado in cui una persona usufruisce a pieno delle possibilità/opportunità importanti della sua vita.*

Nota la parola chiave in entrambe: **percezione**. La QdV non è misurabile solo dall'esterno — dipende da come la persona vive la propria situazione.

## Gli 8 domini della QdV

Schalock e Verdugo identificano otto dimensioni organizzate in tre aree trasversali:

| Area trasversale              | Dominio                  | Indicatori principali                             |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Indipendenza</b>           | Sviluppo personale       | Educazione, abilità, comportamento adattivo       |
| <b>Indipendenza</b>           | Autodeterminazione       | Scelte, autonomia, controllo personale, obiettivi |
| <b>Partecipazione sociale</b> | Relazioni interpersonali | Rete sociale, amicizie, attività sociali          |
| <b>Partecipazione sociale</b> | Inclusione sociale       | Integrazione/partecipazione nella comunità        |

| Area trasversale              | Dominio              | Indicatori principali                          |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Partecipazione sociale</b> | Diritti              | Umani (dignità, uguaglianza) e legali          |
| <b>Benessere</b>              | Benessere emozionale | Sicurezza, esperienze positive, concetto di sé |
| <b>Benessere</b>              | Benessere fisico     | Salute, nutrizione, esercizio fisico           |
| <b>Benessere</b>              | Benessere materiale  | Stato finanziario, lavorativo, abitativo       |

Pensa a questi domini come le radici di un albero: se una radice non sta bene, tutto l'albero ne risente. Non puoi guardare solo il tronco e pensare di capire la salute dell'albero.

## I 7 principi del paradigma QdV

(Carbonari, 2017; Schalock e Verdugo)

1. **Multidimensionalità** — superamento degli approcci unidimensionali (es. "chi sta bene è chi ha soldi")
2. **Visione olistica** — i domini si influenzano reciprocamente; ogni modifica in un dominio ha effetti trasversali
3. **Temporalità** — i valori attribuiti variano nel corso della vita (prospettiva longitudinale)
4. **Variabilità personale** — ogni persona dà importanza diversa ai singoli domini
5. **Soggettività + oggettività** — vanno considerati sia elementi oggettivi (reddito, salute fisica) sia la narrazione soggettiva della persona
6. **Empowerment** — aspetti legati all'emancipazione e alla partecipazione attiva
7. **Estendibilità** — il modello vale per **tutte le persone**, non solo per quelle con disabilità

La professoressa ha sottolineato con un esempio molto concreto: una persona con ADHD in una società caotica può vivere la sua condizione come meno invalidante

che in una società rigidamente strutturata. Il contesto sociale **co-costruisce** la qualità di vita.

---

## Salute e malattia: una visione tripartita

### La definizione dell'OMS

La **Carta di Ottawa (1986)** definisce la salute come:

«Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità.»

La salute non è uno scopo in sé — è una **risorsa per la vita quotidiana**. Un mezzo, non un fine. La pace, le risorse economiche, il cibo, l'abitazione, un ecosistema stabile sono pre-requisiti necessari per la salute — che quindi non è solo una questione individuale, ma un diritto sociale.

Come ha sottolineato la classe: questa definizione del 1948 è ancora rivoluzionaria. Implica che pochissimi di noi siano "in salute" se intendiamo la salute come stato di **completo** benessere.

### Il concetto triadico di Twaddle: disease, illness, sickness

Questa è una distinzione fondamentale per il lavoro sociale — imprimila bene.

- **Disease** — la malattia biologica oggettiva, quella che il medico diagnostica con sintomi e segni clinici
- **Illness** — il vissuto soggettivo del mal-stare, la percezione personale mediata anche dal background culturale
- **Sickness** — l'interpretazione sociale e culturale della malattia, con i diritti e gli obblighi che ne derivano

Esempio pratico: due persone con la stessa diagnosi (disease uguale) possono vivere la malattia in modo completamente diverso (illness diversa) e ricevere risposte diverse dalla società (sickness diversa). L'esperienza umana costruisce la malattia in tutti i suoi aspetti.

## Benessere collettivo

Il benessere non è solo individuale. Secondo [Dal Pra Ponticelli \(2007\)](#), il **benessere collettivo** è:

«Sensazione positiva collettiva determinata dalla percezione di sentirsi riconosciuti come collettività, di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale, poter usufruire di beni, servizi e di condividere una solidarietà sociale.»

Quindi anche lavorare per il benessere del singolo richiede, in parallelo, di lavorare per una società più equa e inclusiva.

---

## Modello PERMA: il benessere individuale secondo Seligman

[Martin Seligman](#) — fondatore della **psicologia positiva** — ha sviluppato nel **2011** il modello **PERMA** per descrivere il benessere individuale come **flourishing** (funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente).

Il PERMA nasce dopo una revisione critica della sua prima "Teoria della felicità autentica" (2002): Seligman si rende conto che la felicità è un termine troppo limitante, e che il vero obiettivo non è la soddisfazione di vita soggettiva, ma un costrutto più ampio e multidimensionale.

| Lettera  | Elemento                                 | Descrizione                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> | Positive Emotions —<br>Emozioni positive | Atteggiamento positivo verso passato (orgoglio), presente (gioia), futuro (speranza)                                               |
| <b>E</b> | Engagement —<br>Coinvolgimento           | Essere completamente presenti in ciò che si fa; il concetto di <b>flow</b> (la sensazione di essere nel flusso, che il tempo vola) |
| <b>R</b> |                                          |                                                                                                                                    |

| Lettera  | Elemento                              | Descrizione                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Relationships —<br>Relazioni positive | Costruire legami forti con familiari, amici, colleghi; impatto diretto su salute e resilienza               |
| <b>M</b> | Meaning — Significato                 | Sentire che la propria vita ha un senso; credere in qualcosa di più grande di sé (missione, comunità, fede) |
| <b>A</b> | Accomplishment —<br>Realizzazione     | Consapevolezza di aver raggiunto traguardi; alimenta autostima e ottimismo (principio di autoefficacia)     |

Pensa al PERMA come ai cinque pilastri di un edificio: se ne manca uno, la struttura è meno stabile. Nel lavoro sociale, promuovere il flourishing significa lavorare su più di questi pilastri contemporaneamente.

---

## Empowerment: dal potenziamento individuale all'approccio relazionale

### Definizione dell'OMS

«L'empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni.»

Il termine nasce dai movimenti di emancipazione afroamericani negli Stati Uniti — ha origini politiche e conflittuali, non burocratiche. Oggi viene usato in modo più soft, ma è importante ricordare la radice: è un concetto legato al **potere** e alla possibilità di esercitarlo.

## Empowerment individuale vs. di comunità

- **Empowerment individuale** — capacità del singolo di prendere decisioni e assumere il controllo della propria vita
- **Empowerment di comunità** — individui che agiscono collettivamente per influenzare i determinanti di salute e QdV nella propria comunità

## L'approccio postmoderno: empowerment relazionale

Folgheraiter (2004) introduce il concetto di **empowerment relazionale**, legato al lavoro di rete:

Processo collaborativo di apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli individui e delle collettività, per accrescerne la possibilità di autodeterminazione.

In questo approccio: - Gli esperti **cedono** parte del loro potere di trovare soluzioni alle persone con cui lavorano - L'utente diventa un **agente attivo** (non passivo ricevente di cure) - Il ruolo dell'operatore diventa di **orientamento, accompagnamento e sostegno** — non di sostituzione direttiva - **Il cedere potere non è una perdita: quando il potere è scambiato e intrecciato, si ri-genera e si moltiplica**

Principi operativi dell'empowerment relazionale (Folgheraiter): 1. Processo collaborativo: utenti, carer, operatori come partner 2. Utenti visti come potenzialmente competenti e capaci di decidere 3. Utenti capaci di autopercepirsi come agenti di cambiamento 4. Competenza acquisita attraverso l'esperienza, non ceduta dall'operatore 5. Operatori che non sostituiscono, ma **aspettano, sostengono e orientano** l'azione

---

## Autonomia: non uno stato, ma un processo

### Definizione (Tramma, 2018)

«La condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie azioni, scelte, comportamenti, tenendo conto di se stessi e dei fattori che entrano

in gioco nel proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di dipendenze funzionali che lega il soggetto agli altri.»

Etimologicamente: dal greco *autos* (se stesso) + *nomos* (legge) = governarsi con leggi proprie.

**Attenzione: autonomia non significa isolamento o assenza di dipendenza.**  
Nessun essere umano è autonomo in senso assoluto — tutti siamo inseriti in reti di dipendenze funzionali con gli altri.

## **Autonomia come processo (Meirieu)**

Il pedagogo **Philippe Meirieu** propone di parlare di **processo di autonomizzazione** — non si "è" autonomi, ci si "diventa" progressivamente.

L'operatore deve:

«Sforzarsi di rendere il soggetto autonomo. Non supporlo già autonomo, ma organizzare un sistema di aiuti che gli permetta di raggiungere gli obiettivi che si fissa, prima di portarlo a fare progressivamente a meno di questi aiuti e ad applicare per conto suo, di sua iniziativa e in altre situazioni quello che ha acquisito.»

Il livello di autonomia deve sempre essere: - Definito a partire dal livello già raggiunto dalla persona - Un livello **superiore** ma **accessibile** (come salire un gradino alla volta, non tutta la scala in un colpo)

## **La finta autonomia e l'abbandono (Tramma, 2018)**

Tramma segnala un rischio importante: confondere la vera autonomia raggiunta con la **finta autonomia** che maschera l'abbandono del servizio. In un momento di crisi del welfare state, c'è il rischio di usare il "fare da sé" come pretesto per ridurre i servizi, non per promuovere la crescita della persona.

## **Può essere necessario limitare l'autonomia?**

Sì — in alcuni casi (protezione dei minori, situazioni di pericolo) **limitare temporaneamente l'autonomia serve per raggiungere una maggiore**

**autonomia nel lungo termine.** Non è una contraddizione: è una scelta educativa consapevole e contestualizzata.

---

# Autostima vs. Autoefficacia: due concetti distinti

Questi due termini vengono spesso confusi — per l'esame è fondamentale conoscere la differenza.

## Autostima

Dal latino *aestimare* = determinare il valore di. L'**autostima** è il **giudizio di valore personale** — come mi valuto come persona.

È determinata da: - Le aspettative dell'individuo su sé stesso - La raggiungibilità dei modelli di riferimento - La qualità delle relazioni sperimentate - I feedback ricevuti in ambito sociale, lavorativo, affettivo

## Autoefficacia (Bandura, 2012)

«Le convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati.»

L'**autoefficacia** è il **giudizio di capacità personale** in uno specifico contesto — "sono capace di fare *questa cosa* in *questa situazione*?"

È il **motore motivazionale** dell'agentività umana: se penso di non essere capace di produrre un effetto su una situazione, non investo energie nell'azione. Non è una misura delle competenze possedute, ma della **credenza** in ciò che sono in grado di fare.

## La differenza chiave (Bandura)

|         | Autostima                    | Autoefficacia                      |
|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Domanda | "Quanto valgo come persona?" | "Sono capace di fare questa cosa?" |

|                         | <b>Autostima</b>             | <b>Autoefficacia</b>              |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo di giudizio</b> | Valore personale             | Capacità specifica                |
| <b>Ambito</b>           | Globale                      | Specifico per attività/contesto   |
| <b>Esempio</b>          | "Sono una persona di valore" | "Riuscirò a passare questo esame" |

Esempio della professoressa: posso essere bravissima con Excel (alta autoefficacia in quel dominio) senza che questo mi dia autostima — se per me quel dominio non ha valore. Viceversa, posso non saper disegnare (bassa autoefficacia nel disegno) senza che questo intacchi il mio valore di persona.

---

## Concetti chiave

| <b>Termine</b>                 | <b>Significato</b>                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualità di Vita (QdV)</b>   | Multidimensionale; percezione soggettiva della propria posizione rispetto a 8 domini (Schalock e Verdugo) |
| <b>Flourishing</b>             | Funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente (Seligman)                                  |
| <b>PERMA</b>                   | Modello del benessere: Emozioni positive, Engagement, Relazioni, Significato, Realizzazione               |
| <b>Flow</b>                    | Stato di massimo coinvolgimento e assorbimento in un'attività (componente E del PERMA)                    |
| <b>Empowerment</b>             | Processo di acquisizione di potere decisionale sulla propria vita, individuale e collettivo               |
| <b>Empowerment relazionale</b> | Approccio postmoderno: potere condiviso tra operatori e utenti come partner (Folgheraiter)                |
| <b>Autonomia</b>               |                                                                                                           |

| Termine                             | Significato                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Capacità di governarsi con leggi proprie nella rete di dipendenze; processo, non stato fisso |
| <b>Processo di autonomizzazione</b> | Percorso graduale verso l'autonomia (Meirieu)                                                |
| <b>Autostima</b>                    | Giudizio di valore personale (Bandura)                                                       |
| <b>Autoefficacia</b>                | Giudizio di capacità personale in un dominio specifico (Bandura)                             |
| <b>Disease</b>                      | Malattia biologica oggettiva (Twaddle)                                                       |
| <b>Illness</b>                      | Vissuto soggettivo del mal-stare (Twaddle)                                                   |
| <b>Sickness</b>                     | Interpretazione sociale/culturale della malattia (Twaddle)                                   |

## Domande di orientamento allo studio

**Cosa si intende oggi per promozione della Qualità di Vita e quali sono i domini che la costituiscono?** La Qualità di Vita (QdV) è intesa come la percezione soggettiva dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento (OMS, 1995). Il modello di Schalock e Verdugo (2006/2008) identifica 8 domini organizzati in tre aree: **indipendenza** (sviluppo personale, autodeterminazione), **partecipazione sociale** (relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti) e **benessere** (emozionale, fisico, materiale). I domini si influenzano reciprocamente — un cambiamento in uno ha effetti trasversali su tutti gli altri. La parola chiave è "percezione": la QdV non si misura solo dall'esterno, ma dipende da come la persona vive la propria situazione.

**Quali sono i principi di funzionamento del modello QdV?** Il modello QdV si fonda su 7 principi (Carbonari, 2017; Schalock e Verdugo): multidimensionalità (superamento degli approcci unidimensionali), visione olistica (i domini si influenzano reciprocamente), temporalità (i valori variano nel tempo), variabilità personale (ogni persona pesa diversamente i domini), soggettività e oggettività

insieme (entrambe necessarie), empowerment (emancipazione della persona), ed estendibilità a tutte le persone (non solo quelle con disabilità). Il contesto sociale co-costruisce la qualità di vita — la stessa condizione può essere vissuta in modo molto diverso a seconda del contesto.

**Cosa caratterizza il concetto di benessere nel modello PERMA? Cosa si intende per flourishing?** Il modello PERMA (Seligman, 2011) descrive il benessere individuale come **flourishing** — funzionamento ottimale: non solo stare bene, ma funzionare efficacemente. Si compone di cinque elementi: **Positive Emotions** (emozioni positive verso passato, presente e futuro), **Engagement** (coinvolgimento totale in ciò che si fa, incluso il concetto di flow), **Relationships** (relazioni positive e legami forti), **Meaning** (sentire che la propria vita ha senso), **Accomplishment** (traguardi raggiunti, autostima, ottimismo). Ogni elemento contribuisce al benessere in modo indipendente e intrinsecamente motivato.

**Come si è evoluto il concetto di empowerment nel lavoro sociale e qual è l'accezione postmoderna di empowerment relazionale?** L'empowerment nasce dai movimenti di emancipazione afroamericani con radici politiche e conflittuali. Nel lavoro sociale si declina come processo sociale, culturale, psicologico e politico che permette alle persone di esprimere bisogni, partecipare al processo decisionale e agire per soddisfarli (OMS). La versione classica distingue tra empowerment individuale (controllo sulla propria vita) e di comunità (azione collettiva). L'**empowerment relazionale** (Folgheraiter, 2004) è l'accezione postmoderna: gli esperti cedono parte del loro potere di trovare soluzioni agli utenti, che diventano partner attivi. Il ruolo dell'operatore diventa di orientamento, accompagnamento e sostegno — non di sostituzione. Il potere ceduto non si perde, si moltiplica.

**Quali sono le principali caratteristiche e differenze tra autonomia, autostima e autoefficacia?** L'**autonomia** (Tramma, 2018) è la capacità di governarsi con leggi proprie nella rete di dipendenze — non assenza di dipendenza, ma processo graduale (autonomizzazione, Meirieu). L'operatore organizza aiuti graduali che vengono progressivamente ridotti. L'**autostima** è il giudizio di valore personale ("quanto valgo come persona?"), determinato da aspettative su sé stessi, modelli di riferimento e feedback ricevuti. L'**autoefficacia** (Bandura, 2012) è il giudizio di capacità specifica in un determinato contesto ("sono capace di fare

questa cosa?") — è il motore motivazionale che determina se la persona investe energie nell'azione. La differenza chiave: posso avere alta autoefficacia in un'attività (sono bravissimo con Excel) senza che questo mi dia autostima, e viceversa.

---

## Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** il concetto di autonomia e di lavoro *con* le persone richiama la definizione di lavoro sociale e il principio del rispetto dell'autodeterminazione (Lezione 01–02)
- **Temi aperti / da approfondire:**
  - Il conflitto tra autonomia individuale e autonomia collettiva (es. come gestire quando l'autonomia del singolo entra in contrasto con il benessere della comunità?)
  - Il confine tra vera autonomia e abbandono mascherato da "fare da sé"
  - Come misurare la QdV in pratica (strumenti di osservazione e valutazione)
  - L'empowerment relazionale nel progetto individuale: come si traduce operativamente?